

Status main et poignet

Cas clinique : fourmillements (patient imite un syndrome du tunnel carpien)

Désinfection !

1. Inspection (décrire) :

- a) Rougeur
- b) Tuméfaction
- c) Amyotrophie (éminence thénar, loge 1^{er} interosseux, éminence hypothénar)

2. Palpation :

- a) Éminence thénar, loge 1^{er} interosseux, éminence hypothénar
- b) Vascularisation : gradient thermique, temps de recoloration paume/doigts
- c) Trajet n. médian (palper assez fortement, douleur ?)
- d) Trajet n. ulnaire (+ positionner un doigt dans l'espace entre l'épicondyle médial et l'olécrane avec mobilisation du coude pour sentir le nerf ulnaire coulisser, douleur ?)

3. Sensitif :

- a) Au touché (patient ferme les yeux, **10 demi-pulpes, 2 paumes/2 dos, 3 avant-bras**)
- b) Si anormal = toucher/piquer (hypoesthésie/dysesthésie/hypo-dysesthésie/allodynie)
- c) Si anormal = discrimination entre deux points (si >5mm et détecte qu'un point, anesthésie)

4. Motricité distale (tendons + muscles) :

- a) Fléchisseur profond des doigts (avec pouce)
- b) Fléchisseur superficiel des doigts (immobiliser les autres doigts)
- c) Abduction du **pouce** (demander au patient d'amener son pouce vers son nez + R, dos de la main sur la table) → **test n. médian**
- d) Abduction **index** (main posée sur le côté, demander de lever l'index contre R) et **auriculaire** (demander d'écarter l'auriculaire contre R) → **test n. ulnaire**
- e) Extension des doigts → **test n. radial**

5. Tests spécifiques :

- a) **Signe de Tinel** (compression n. médian via percussion, tapoter fort sur trajet du n. médian dans canal carpien pendant 1 min ou jusqu'à provocation des symptômes, ddc en même temps, valable pour tous les nerfs) → positif si provoque fourmillements, électricité, douleur dans partie distale des doigts 1-3
- b) **Signe de Phalen** (compression n. médian via flexion poignet, patient avec avant-bras reposés sur la table, forcer la flexion passivement, ddc en même temps, pendant 1 min ou jusqu'à provocation des symptômes) → positif si douleur ou fourmillements dans partie distale doigts 1-3
- c) **Signe de Durkan** (compression directe n. médian) → positif si douleurs ou paresthésies du poignet déclenchées par pression au niveau du canal carpien, *les deux en même temps*
- d) Mobilisation de la tête (+/- **Spüring** : tête en extension latérale puis appuyer sur la tête)

DD : Syndrome du tunnel carpien, syndrome du tunnel cubital, radiculopathie cervicale

Prise en charge : proposer le port d'une attelle nocturne pendant 6 semaines, si pas d'amélioration proposer un examen ENMG/US.